



FICHE BONNE CONDUITE n° 32 - PORTAGE & MOTRICITÉ DE L'ENFANT

CATEGORIE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE

Le portage est indispensable au bon développement de l'enfant, cependant je dois le réaliser de façon appropriée pour ne pas le blesser, favoriser son bon développement et l'aider à rester acteur du maintien de son corps. Par ailleurs, lorsque l'enfant grandit et commence à se déplacer seul, il est important que je l'accompagne dans sa motricité.

REGLES D'OR ✓

- ✓ **J'échange avec la famille en amont**, notamment sur les techniques de portage qu'elle utilise et je m'adapte à ses habitudes.
- ✓ En fonction de l'autonomie et de l'âge de l'enfant, **j'adapte mon accompagnement et mes gestes**.
- ✓ J'explique à l'enfant comment je vais procéder et **je procède par étapes**, même s'il s'agit d'un bébé.
- ✓ Je fais preuve de **douceur, de calme et de prévenance** lorsque je porte un enfant ou l'accompagne dans sa motricité. Je n'effectue pas de mouvements brusques ou de déplacements rapides
- ✓ J'agis de façon à ce que l'enfant se **sente en sécurité**. Je veille à sa sécurité lors des déplacements (ex : escaliers).
- ✓ **Je ne porte un bébé en écharpe** que si j'ai été **formé** à cette technique et si cela est demandé par les parents.

POINTS DE VIGILANCE ✗

- ✓ Je suis **vigilant au risque de chute** (encombrement du passage, état de fatigue, éclairage, enfant assis en hauteur, lacets défaits, chaussures inadaptées, port de lunettes...). Ainsi **je ne porte pas en même temps un enfant et autre chose** (ex : poussette, plat chaud etc.)
- ✓ Je m'assure que les **voies respiratoires du bébé soient toujours dégagées** et que je peux voir son visage (ex : visage dégagé du tissu lors du portage en écharpe)
- ✓ **Je ne prends jamais un nourrisson de moins de 6 mois par les aisselles pour le soulever**. Cela raidit son dos et peut être dangereux.
- ✓ En cas de doute sur la pratique, ou en cas de questionnement par rapport à la sécurité de l'enfant, **j'en échange avec la famille**, que j'essaie de sensibiliser aux risques. Si la famille insiste, je me réfère à l'association avant de d'agir.

Comment soulever un bébé de 0 à 6 mois?



1. Tout le long des prochaines étapes, **je garde le dos droit et la tête tournée vers l'avant**. Pour protéger mon dos, je m'assure que mes fesses sont repoussées vers l'extérieur pendant que je me penche. Quelle que soit la position de départ du bébé (ex : au sol, dans son lit etc.), je place toujours **une main sous ses fesses et l'autre main au niveau de sa tête**. Ses genoux doivent être repliés sur son ventre. Le bébé est alors en position semi-arrondie. Ma main doit toujours soutenir son crâne plutôt que sa nuque.
2. Si le bébé est au sol, je place un **pied près de lui et je m'abaisse sur un genou**. Je le fais glisser **de mon genou à la cuisse** et je le place sur la cuisse opposée.
3. Qu'il soit au sol ou sur une surface plus haute, avant de me relever, je place mes deux avant-bras sous le bébé et je l'approche de ma poitrine. De la même façon, je fais attention à bien le reposer, toujours dans une position semi-arrondie et en soutenant bien sa tête. Il est préférable de le déposer sur le côté, puis de le faire rouler pour le mettre sur le dos.



Comment porter un enfant de moins d'un an ?

• De 0 à 3 mois :

Jusqu'à ses 3 mois environ, un bébé n'est pas capable de bien tenir sa tête. Il faut donc toujours veiller à bien accompagner sa tête, quelle que soit la position choisie :

- Je peux le porter **contre moi**, ventre contre ventre, la tête en appui sur mon épaule, tout en maintenant ses fesses avec ma main.
- Je peux le porter **sur le dos**, dans le creux de mon bras, sa tête posée au niveau de votre coude et la main soutenant les fesses.
- **En cas de colique**, pour le calmer, je peux le coucher sur le ventre à califourchon sur mon avant-bras, avec beaucoup de précaution et veillant à bien le tenir. Je glisse une main sous son ventre en le maintenant au niveau des hanches. Pour limiter les tensions, le bébé doit avoir les jambes et les bras qui pendent.



• De 3 à 6 mois :

A partir de 3 mois, le bébé commence à être curieux et va vouloir observer ce qui l'entoure. Néanmoins, il ne tient pas encore forcément bien sa tête.

- Je peux adopter les **mêmes positions que pour la phase 0 à 3 ans**
- Je peux mettre son **dos contre moi**, une main sur sa poitrine et une autre sous ses fesses ou bien glissée dans son entrejambe.



• Après 6 mois :

A partir de 6 mois, parfois même plus tôt, le bébé est suffisamment musclé pour maintenir sa tête correctement. Je peux alors porter **sur ma hanche**, que ce soit dos ou face à moi en fonction de la situation.



Quand et comment poser un bébé au sol sur un tapis d'éveil?

- Je ne mets un bébé au sol uniquement si j'ai l'**autorisation des parents, et je ne le laisse jamais sans surveillance.**
- **Je le place toujours au sol sur le dos** sur un **support dédié** molletonné (tapis d'éveil, tapis de sport...).
- Si le bébé parvient à se retourner sur le ventre, je m'assure qu'il ne sorte pas du tapis d'éveil, qu'il ne se cogne pas la tête et qu'il ne reste pas plus de quelques minutes dans cette position. Je l'aide à se remettre sur le dos dès les premiers signes de fatigue.
- **Le temps passé au sol dépend de son âge et de son niveau de développement :**
 - Jusqu'à 3 mois : Il est recommandé de réserver des temps courts jusqu'à maximum 15 minutes de séances sur le tapis d'éveil.
 - De 4 à 6 mois : de 20 à 30 minutes par séance
 - Après 6 mois : une heure ou plus selon son intérêt.



Comment accompagner la motricité du jeune enfant ?

1. Je l'encourage à **se déplacer à son rythme et dans la posture qu'il souhaite** (quatre-pattes, au sol, debout, assis...) par des encouragements verbaux (compter à voix haute les pas faits, le féliciter, l'inciter à continuer...).
2. Je propose des **jeux qui favorisent l'apprentissage de nouveaux mouvements** (danse, jouer à chat, cache-cache...).
3. Je **veille à sa sécurité et lui explique les règles de sécurité** et comment utiliser un équipement de jeu avec prudence.

Comment réagir si l'enfant chute ?

1. **Je garde mon calme et évalue rapidement les symptômes et signes de blessures** afin de voir si une prise en charge par des professionnels de santé est nécessaire. Les signaux alertant peuvent être les suivants : perte de conscience, respiration anormale ou lente, perte de sang, zone de la tête gonflée, blessure grave, vomissement, pleurs incontrôlés, somnolence, confusion, désorientation...
2. Si un ou plusieurs de ces signes apparaissent toute de suite ou dans les heures qui suivent, **j'appelle immédiatement le SAMU (au 15) ou les pompiers (au 18)** et l'association.
3. Dans le cas d'une chute grave et d'une blessure à la tête ou à la colonne vertébrale, **je ne déplace pas l'enfant** (sauf en cas de danger).
4. Si celui-ci **vomit ou s'il a des convulsions**, je le tourne doucement sur le côté. S'il s'agit d'un bébé, je m'assure de garder son cou droit tout en le retournant.
5. Si l'enfant ne montre aucun signe visible de blessure et ne semble pas agir différemment, **je le surveille de près** et l'interroge sur son état quand cela est possible.
6. **En cas de doute, j'appelle le SAMU (au 15) ou les pompiers (au 18)** et le responsable de service.
7. Je préviens les parents de la situation.

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Lors des déplacements ou lorsque je porte un enfant, **je protège mon dos**. Plus le poids est loin du corps, plus la colonne vertébrale est mise à contribution.
- ✓ **Je travaille avec les jambes et je plie les genoux**, surtout lorsque je me baisse
- ✓ J'évite les **torsions du dos**.
- ✓ Je limite les risques de chute en me déplaçant sans précipitation, en dégageant les accès (ex : escalier encombré) et en évitant de porter plusieurs choses en même temps, en particulier si j'ai un enfant dans les bras.
- ✓ Si je rencontre des difficultés récurrentes dans ma pratique professionnelle, **j'en parle à mon association pour trouver une solution**.